

PLAN DE INTERVENCIÓN DE ATENCIÓN TEMPRANA DE REVISIÓN (PIAT)

El PIAT es un programa de atención global e individualizado, que recoge las características de cada menor y de su entorno, una valoración exhaustiva del desarrollo del mismo y los objetivos planteados en la intervención. En él se recogen las aportaciones tanto de los diversos profesionales del Servicio que intervienen en el proceso como de la familia, lo cual les permitirá descubrir sus propios recursos y, a la vez, reforzar la relación con su hija/o, aspecto muy importante para su evolución madurativa y afectiva. Se actualiza de forma frecuente en función de las necesidades y la evolución del menor y su familia.

INFORMACIÓN DIAGNÓSTICA Y MÉDICA :

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL O.D.A.T. (Organización Diagnóstica de Atención Temprana):

4.g.g. Disfasia (TEDL) o (TPDL).

Diagnóstico Principal del CAIT : 4.k. Trastorno del desarrollo del lenguaje (TEDL).

ANTECEDENTES PERSONALES :

Segundo hijo de la pareja. Embarazo natural, controlado y bien tolerado. La madre presenta trombofilia en tratamiento con heparina durante la gestación. Parto a término en la semana 39 mediante cesárea programada por presentación de nalgas. Apgar 9/10. Peso 3.200 g, talla 50 cm y perímetro craneal 35 cm. No precisó reanimación. OEA y EIM normales. Lactancia artificial. Ingreso a los 47 días de vida en UCI por bronquiolitis moderada con necesidad de VMNI. Sin alergias ni patologías crónicas conocidas. No intervenciones ni tratamientos farmacológicos actuales.

ANTECEDENTES FAMILIARES:

Hermano de 9 años con desarrollo típico. No consanguinidad. No se refieren antecedentes familiares relevantes de trastornos del neurodesarrollo o del lenguaje.

OTROS DATOS DE SALUD DE INTERÉS :

Centro de salud de referencia: Gines.

En seguimiento por ORL y pediatría, sin hallazgos patológicos.

Sin otras derivaciones médicas activas.

DATOS DE ESCOLARIZACIÓN :

Centro Escolar: CEIP NUESTRA SEÑORA DE BELEN

Curso: 2º ciclo E. Infantil 3 años.

Acude contento y se encuentra bien integrado, participando en actividades colectivas.

ASPECTOS BIOPSIICOSOCIALES :

ESTADO FÍSICO GENERAL:

Buen estado general de salud. Desarrollo somático y proporciones corporales adecuadas para la edad. Se desplaza de forma autónoma con buen patrón de marcha. No se observan alteraciones significativas en la coordinación motora gruesa ni en las destrezas manipulativas, apreciándose evolución favorable respecto a valoraciones previas.

ASPECTOS EMOCIONALES DEL NIÑO/A:

Alejandro se muestra generalmente alegre, tranquilo y colaborador durante las sesiones de intervención. Mantiene buen contacto ocular, acepta compartir el juego con el adulto y presenta buena disposición hacia las actividades propuestas. Tolerancia adecuadamente los cambios de actividad y las rutinas de sesión. De forma puntual ha mostrado menor colaboración coincidiendo con situaciones de cansancio, aunque no constituye una dificultad significativa en el contexto terapéutico.

ASPECTOS EMOCIONALES DE LOS CUIDADORES PRINCIPALES:

Los padres continúan mostrando una adecuada implicación y adherencia al proceso terapéutico. Mantienen buena coordinación con los profesionales y actitud receptiva hacia las orientaciones propuestas, favoreciendo la generalización de objetivos en el entorno familiar. Presentan un estilo educativo afectivo y estructurado, ajustado a las necesidades evolutivas del menor.

CONSIDERACIONES DEL ENTORNO FAMILIAR:

Alejandro reside en el domicilio familiar en Gines junto a su madre Desiree González Ojeda (técnica de enfermería), su padre Alejandro Tercero Gil (empleado de banca) y su hermano David, con desarrollo típico. Padres convivientes, entorno socioeconómico estable y adecuada red de apoyo familiar.

CONDUCTA:

En sesión presenta una conducta generalmente adecuada, mostrando buena adaptación a las actividades y normas básicas. No se observan conductas disruptivas significativas ni rabietas frecuentes.

A nivel atencional se aprecian dificultades para mantener una atención sostenida y para inhibir respuestas impulsivas, especialmente en tareas estructuradas relacionadas con el lenguaje. Tiende a emitir respuestas automáticas o perseverativas sin analizar adecuadamente el estímulo presentado, mostrando dificultad para modificar la respuesta inicial incluso tras recibir corrección o apoyo verbal.

SOCIABILIDAD:

Busca la interacción con adultos e iguales, mostrando sonrisa social y buena respuesta emocional en contextos conocidos. Se observa evolución favorable en la interacción social y en la participación compartida durante el juego, tanto con iguales como con adultos de referencia, aunque las limitaciones en el lenguaje continúan interfiriendo parcialmente en sus habilidades comunicativas y sociales.

RED DE APOYO PROFESIONAL:

Recibe por el CAIT 1 sesión a la semana de las especialidades de logopedia.

EXPLORACIÓN MEDIANTE PRUEBAS ESTANDARIZADAS

PRUEBAS Y RESULTADOS:

Se administra Inventario de Desarrollo Battelle el 19/05/2026 con los siguientes resultados:

Área	Puntuación Directa	Percentil	Edad Equivalente
Personal/Social	107	14	34 meses
Adaptativa	70	12	35 meses
Motora	103	37	38 meses
Motora Gruesa	64	64	45 meses
Motora Fina	39	16	35 meses
Comunicación	51	2	32 meses
Comunicación Receptiva	25	17	37 meses
Comunicación Expresiva	26	3	28 meses
Cognitiva	47	41	41 meses
Total	378	11	36 meses

Interpretación:

Perfil evolutivo compatible con mejoría global respecto a valoración previa, observándose avances especialmente en las áreas cognitiva, motora y comunicativa. El área más afectada continúa siendo la comunicación, principalmente a nivel expresivo, persistiendo un desfase significativo respecto a la edad cronológica. Las dificultades atencionales y la impulsividad en la respuesta interfieren en el rendimiento

lingüístico y adaptativo del menor, condicionando parcialmente su desempeño en tareas de comprensión y comunicación funcional.

EXPLORACIÓN CUALITATIVA DEL DESARROLLO ACTUAL

DESARROLLO MOTOR:

Presenta marcha independiente con buen equilibrio y coordinación motora adecuada para la edad. Se observa evolución favorable en motricidad fina y manipulación funcional de objetos, aunque en tareas de precisión aún puede apreciarse cierta inmadurez acorde al perfil evolutivo general.

DESARROLLO COGNITIVO:

Muestra buena capacidad de aprendizaje mediante apoyo visual y modelado. Comprende consignas simples y contextualizadas, manteniendo interés por las actividades propuestas. Se observan avances en habilidades cognitivas generales y resolución de tareas funcionales. No obstante, persisten dificultades relacionadas con la atención sostenida, la impulsividad y la inhibición de respuestas automáticas, lo que interfiere en determinadas tareas estructuradas y en el procesamiento adecuado de la información verbal. Precisa frecuentes redirecciones atencionales para optimizar el rendimiento.

DESARROLLO COMUNICATIVO:

Se aprecia evolución favorable en la intención comunicativa y en el uso funcional del lenguaje. Ha aumentado el repertorio léxico y la frecuencia de emisiones espontáneas respecto a valoraciones previas. Actualmente realiza producciones verbales más complejas, llegando a combinar frases de tres y hasta cuatro elementos, aunque gran parte de las emisiones resultan todavía poco inteligibles.

Continúa utilizando gestos comunicativos como apoyo al lenguaje oral y muestra buena iniciativa comunicativa en contextos conocidos. La comprensión verbal ha mejorado, especialmente en situaciones funcionales y apoyadas visualmente, aunque el rendimiento puede verse condicionado por dificultades atencionales e impulsividad en la respuesta.

DESARROLLO ADAPTATIVO:

Participa de forma funcional en rutinas básicas de autonomía personal, mostrando buena disposición para colaborar en actividades de la vida diaria. Se observan progresos acordes a la evolución general del menor. Las dificultades atencionales continúan interfiriendo parcialmente en la autonomía funcional y en el seguimiento adecuado de consignas complejas.

PREOCUPACIONES ACTUALES DE LA FAMILIA

La familia de Alejandro se muestra más preocupada por el área del lenguaje.

OBJETIVOS FUNCIONALES

OBJETIVOS CONSEGUIDOS

- Mejora de la imitación gestual y vocal.
- Aumento de la comprensión y expresión verbal mediante palabras funcionales.
- Incremento del uso de gestos comunicativos funcionales (señalar, mostrar, pedir).
- Desarrollo de oraciones simples de dos elementos.
- Consolidación de rutinas básicas de autonomía personal.

OBJETIVOS NO CONSEGUIDOS O EN PROCESO DE CONSECUCIÓN

- Potenciar la atención conjunta.

OBJETIVOS ACTUALES

NIÑA/O

- Favorecer el desarrollo del lenguaje expresivo mediante emisiones verbales más funcionales y organizadas.
- Aumentar la inteligibilidad del habla en contextos funcionales.
- Favorecer la construcción de frases más complejas y estructuradas.
- Mejorar la comprensión verbal en tareas dirigidas y situaciones funcionales.
- Potenciar la atención sostenida y la capacidad de inhibición de respuestas impulsivas.
- Favorecer la flexibilidad en la respuesta verbal ante distintos estímulos lingüísticos.
- Ampliar el vocabulario funcional y el uso espontáneo del lenguaje oral.
- Reforzar las habilidades de interacción y comunicación con iguales y adultos.
- Generalizar los aprendizajes comunicativos a diferentes contextos y entornos habituales.

FAMILIA:

- Orientar y acompañar a la familia en las necesidades de información relacionadas con la evolución del menor.
- Facilitar estrategias para favorecer el lenguaje funcional y la comunicación espontánea en el entorno familiar.
- Ofrecer pautas para mejorar la atención y reducir las respuestas impulsivas durante actividades cotidianas.
- Favorecer la generalización de objetivos trabajados en sesión al contexto familiar.
- Mantener la implicación y coordinación familiar dentro del proceso terapéutico.

ENTORNO:

- Favorecer la coordinación entre familia, centro educativo y CAIT.
- Promover el uso de estrategias comunicativas y atencionales coherentes en los diferentes entornos del menor.
- Facilitar la adaptación de consignas y apoyos visuales para mejorar el rendimiento comunicativo y atencional.

PROFESIONALES DEL PROCESO TERAPÉUTICO:

Los siguientes profesionales se encuentran participado de forma activa en el proceso terapéutico del/la menor:

Profesional de referencia: ANDREA PANEPINTO LOGOPEDA

SESIONES PAUTADAS:

NIÑO/A: 4

FAMILIA: 1

ENTORNO: 0.5

TOTAL: 5.5

MATERIALES Y RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN:

- Colchonetas, columpios.
- Juegos de estimulación del desarrollo.
- Fichas de estimulación cognitiva.
- Material de psicomotricidad.
- Puzzles y rompecabezas.
- Lecturas relacionadas con las áreas de interés.
- Actividades para entrenar prerrequisitos de lectura y escritura.
- Tareas para la ganancia de autonomía y funcionalidad.
- Programa AITTEA.
- Escalas de desarrollo.

FIRMAS:

Queremos destacar la importancia de que todos los agentes que están involucrados en el desarrollo del niño estemos coordinados y trabajemos en el mismo sentido, para así favorecer y multiplicar sus oportunidades de aprendizaje, de forma que aumenten sus posibilidades de evolución.

Fecha de la firma: 21 de Mayo del 2026

Firmas de la familia

He recibido una copia de este documento, se me ha explicado y he entendido la información que contiene:

SI

NO

He participado como miembro de pleno derecho del equipo de desarrollo del PIAT:

SI

NO

Como miembro de pleno derecho del equipo de intervención y como padre/madre, tutor y/o educador del menor y por tanto principal protagonista, receptor y responsable de intervención, estoy de acuerdo con este documento:

SI

NO

DESIREE GONZÁJEZ OJEDA

ALEJANDRO TERCERO GIL

Firma de los profesionales responsables del PIAT:

ANDREA PANEPINTO

LOGOPEDA

29/2280

